

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada - 7 (GAD-7)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada - 7
Sigla	GAD-7
Autores	Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B.
Año	2006
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Ansiedad y miedo
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme (Screening)
Disponibilidad en español	Sí (García-Campayo et al., 2010)
Acceso/licencia	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Nota curatorial de derechos	Pfizer permite reproducir y distribuir los screeners; no se resolvió un PDF directo estable.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ansiedad y miedo. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme (Screening)
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	7 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia (0 = Nunca, a 3 = Casi todos los días) evaluando las últimas 2 semanas.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional.
Ítems	7 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia (0 = Nunca, a 3 = Casi todos los días) evaluando las últimas 2 semanas.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (0 a 21 puntos). Todos directos.

Regla de corrección	Sumatoria directa (0 a 21 puntos). Todos directos.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Un puntaje ≥ 10 justifica una evaluación clínica formal para TAG.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Alfa de Cronbach de .92. Sensibilidad del 89% y especificidad del 82% para el Trastorno de Ansiedad Generalizada. Ampliamente utilizado en atención primaria y clínica.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Alfa de Cronbach de .92. Sensibilidad del 89% y especificidad del 82% para el Trastorno de Ansiedad Generalizada. Ampliamente utilizado en atención primaria y clínica.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (García-Campayo et al., 2010)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ansiedad y miedo en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B.; 2006.
- Disponibilidad española reportada: Sí (García-Campayo et al., 2010)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Ansiedad y miedo
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 7 ítems.; Unidimensional.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria directa (0 a 21 puntos). Todos directos.
Interpretación	Puntos de corte: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Un puntaje ≥ 10 justifica una evaluación clínica formal para TAG.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada - 7.

Fuente de referencia del catálogo: [PHQ Screeners](https://www.phqscreeners.com/)

<https://www.phqscreeners.com/>

<https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>

<https://www.phqscreeners.com/select-screener>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	GAD-7 española, 7 ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 4c650c82cefcf3993d5bbff3470cb3b76c7aba7d132e4656358577bab16725fc.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	GAD-7 española, 7 ítems.
6. Periodo temporal	Últimas dos semanas.
7. Escala/formato de respuesta	0=Nunca a 3=Casi todos los días.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los siete síntomas 0–3; total 0–21. Referencias usuales 5/10/15 describen niveles de severidad, pero el umbral operativo debe ajustarse al estudio/población. La pregunta funcional adicional no integra la suma.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	García-Campayo et al. validaron la adaptación española en España; los coeficientes y umbrales deben citarse desde el artículo y según contexto clínico.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Severa). Un puntaje ≥ 10 justifica una evaluación clínica formal para TAG. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	El propio formulario PHQ/GAD local declara que no se requiere permiso para reproducir, traducir, mostrar o distribuir; conservar versión y atribución.
13. Referencias y fuentes verificadas	García-Campayo et al. (2010), Health and Quality of Life Outcomes, 8:8, doi:10.1186/1477-7525-8-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20089179/ ; formulario local PHQ Screeners.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.